

Głodny mózg — *priorytet to odżywienie*

AN nie jest „wyborem” ani „słabością charakteru”. Niedożywienie zmienia funkcjonowanie kory przedczołowej. Bez odżywienia psychoterapia jest niemożliwa.

CZAS: 15–20 min psychoedukacji **REALIZACJA:** każdy pacjent + rodzina; uzasadnienie refeedingu

ŹRÓDŁO: Kaye i in. (2013, *Am J Psychiatry*); Frank (2015); Bulik i in. (2006, heritability 50–60%); Keys i in. (1950, *Minnesota Starvation Study*); King i in. (2015, odwrócenie zmian neurostrukturalnych)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **trzy układy neuroprzekaźnikowe** zmienione w AN: dopamina, serotonina, wyspa (ang. *insula*). W sekcji 02 — **niedożywienie a funkcjonowanie mózgu**: dlaczego głodny mózg nie ma dostępu do psychoterapii. Sekcja 03 — **twoja praca**: uzasadnienie kolejności (najpierw odżywienie, potem psychoterapia). Sekcja 04 — co możesz oczekiwać po refeedingu.

DLACZEGO TO DZIAŁA

AN ma solidne podłoże neurobiologiczne — *nie jest „wyborem” ani „buntem”*. Czynniki: dziedziczność (~50–60%, Yilmaz i in., 2015), zmienione neuroprzekaźnictwo (serotonina, dopamina), zaburzenia w korze przedczołowej i prążkowie (Kaye i in., 2013, *Am J Psychiatry*). Głodzenie *samo* zmienia mózg (zob. Minnesota Study) — wiele „cech osobowości” w AN jest skutkiem, nie przyczyną. Psychoedukacja neurobiologiczna redukuje wstyd i wspiera motywację do leczenia.

01 Trzy układy neuroprzekaźnikowe zmienione w AN (Kaye, 2013)

DOPAMINA

Zwiększona reaktywność prążkowia na sygnały głodu. *Paradoks AN*: głodzenie staje się *nagradzające*, sytość — *niepokojąca*. Mechanizm „uzależnienia od kontroli wagi”.

SEROTONINA

Podwyższona aktywność 5-HT1A. Tłumaczy wrażliwość na lęk, perfekcjonizm, sztywność poznawczą. Wspólny mechanizm z OCD i lękiem uogólnionym (komorbidność).

WYSPA (INSULA)

Zaburzona interocepcja — integracja sygnałów z wnętrza ciała. Zaburzona percepcja głodu, sytości, emocji somatycznych. „Nie czuję, że jestem głodny/-a”.

02 ? Minnesota Starvation Study — co głodzenie robi zdrowym osobom

Keys i in. (1950): 36 zdrowych mężczyzn ochotniczo poddano kontrolowanemu niedożywieniu przez 6 miesięcy (utrata około 25% masy). Skutki *u zdrowych osób bez wcześniejszej psychopatologii*: obsesje pokarmowe (myśli o jedzeniu zajmowały godziny dziennie), depresja, lęk, drażliwość, spadek koncentracji, sztywność poznawcza, izolacja społeczna, zmiana osobowości, brak libido.

Implikacja: znaczna część „psychiki AN” to *biologiczna konsekwencja głodzenia*, nie pierwotna cecha pacjenta. Po przywróceniu wagi wiele objawów psychicznych ustępuje samoistnie. **Bez refeedingu psychoterapia ma ograniczoną skuteczność** — głodny mózg *nie* ma dostępu do funkcji wykonawczych i elastyczności potrzebnej do pracy poznawczej.

03 ✎ Co możesz oczekiwać po refeedingu

CO ROZUMIEM O SWOIM MÓZGU W GŁODZIE

— które z trzech układów (dopamina, serotonina, wyspa) widzę u siebie najmocniej

OBJAWY, KTÓRE MOGĄ USTĄPIĆ PO REFEEDINGU

— obsesje pokarmowe, lęk, drażliwość, spadek koncentracji, sztywność, izolacja

PYTANIE DO MOJEGO ZESPOŁU LECZENIA

— „jak długo potrwa odbudowa funkcji mózgu po przywróceniu wagi”, „kiedy zacząć intensywniejszą psychoterapię”

CO POWIEM OSOBIE, KTÓRA MYŚLI „TO MOJA SŁABOŚĆ”

— *biologia, nie wybór; genetyka 50–60%; mózg w głodzie reaguje przewidywalnie*

Klucz: AN *ma podłoże biologiczne*. Heritability 50–60% (Bulik i in., 2006) — to większe niż w depresji. Niedożywienie *fizycznie zmienia* mózg: zmniejsza objętość istoty szarej, zaburza funkcjonowanie kory przedczołowej, zwiększa sztywność poznawczą. Mózg w głodzie *nie* ma dostępu do funkcji wykonawczych — to *nie* jest „brak motywacji”, to *biologia*. Stąd priorytet: **najpierw odżywienie, potem psychoterapia**. Minnesota Starvation Study (Keys i in., 1950) pokazał, że u *zdrowych* osób samo głodzenie wywołuje pełen zestaw „objawów psychicznych AN” — obsesje, lęk, depresję, sztywność. King i in. (2015): zmiany neurostrukturalne są odwracalne, ale zajmuje to 6–12+ miesięcy po przywróceniu wagi. Dla pacjenta: „*to nie twoja wina, to nie twoja słabość*”. Dla rodziny: cierpliwość — odbudowa funkcji mózgu wymaga miesięcy, nie tygodni.

△ „Najpierw odżywienie, potem psychoterapia” *nie* oznacza, że psychoterapia jest pomijana — oznacza, że jej skuteczność jest zależna od stanu mózgu. W praktyce: *minimalne wsparcie psychoedukacyjne i motywacyjne równoległe z odżywieniem* (np. MANTRA, MI), intensywniejsza praca poznawcza dopiero po znaczącym podniesieniu wagi i ustabilizowaniu medycznym. To decyzja zespołu interdyscyplinarnego — psychiatry, dietetyka, psychoterapeuty.